CORPS ET HORMONES

# Ménopause : pourquoi soulever des charges est l'un des meilleurs cadeaux pour tes os

*Après la ménopause, la baisse des œstrogènes accélère la perte de muscle et d'os. Longtemps, on a conseillé la prudence et les petits poids. Une étude australienne a bousculé ces idées : bien encadré, l'entraînement lourd peut renforcer les os.*




SANTÉ AU FÉMININ

POUR NOS CLIENTS ACTIFS · 4 MIN DE LECTURE

Cet article donne des repères généraux. En cas d'ostéoporose connue, de fracture passée ou de traitement, l'avis de ton médecin est indispensable avant de commencer un programme.

01

## Ce qui change après la ménopause

La ménopause marque l'arrêt définitif des règles et la baisse durable des œstrogènes. Ces hormones jouent un rôle protecteur sur de nombreux tissus. Leur diminution a plusieurs conséquences :

- Une accélération de la perte osseuse dans les années qui suivent la ménopause, qui augmente le risque d'ostéoporose et de fracture.
- Une perte progressive de masse et de force musculaire, si l'on ne fait rien pour la contrer.
- Une augmentation du risque cardiovasculaire.
- Une tendance au stockage des graisses au niveau du ventre.

L'Anses, dans ses repères de 2016 sur l'activité physique, a d'ailleurs formulé des recommandations spécifiques pour les femmes ménopausées, en insistant sur le renforcement musculaire et les activités qui sollicitent les os.

02

## L'os est un tissu vivant

On imagine souvent le squelette comme une structure figée. En réalité, l'os se renouvelle en permanence : il est détruit et reconstruit en continu. Et il réagit aux contraintes qu'on lui impose. Quand un muscle tire fortement sur un os, ou quand l'os reçoit un impact, il reçoit le signal de se renforcer.



L'os se renforce quand on le sollicite

C'est pour cela que la natation ou le vélo, excellents pour le cœur, sont moins efficaces pour les os : ils ne les mettent pas assez en charge. Le renforcement musculaire et les activités

avec impacts sont, eux, de vrais stimulants osseux.

> **L'os réagit aux contraintes : plus on le sollicite intelligemment, plus il se renforce.**

03

## L'étude qui a changé le regard

En 2018, une équipe australienne a publié dans le Journal of Bone and Mineral Research les résultats d'un essai baptisé LIFTMOR. Elle a suivi 101 femmes ménopausées qui avaient une masse osseuse basse, c'est-à-dire une ostéopénie ou une ostéoporose.

Pendant huit mois, la moitié d'entre elles a suivi deux fois par semaine un entraînement supervisé de haute intensité : des exercices comme le soulevé de terre, le squat et le développé au-dessus de la tête, en 5 séries de 5 répétitions à plus de 85 % de leur charge maximale, ainsi que des exercices d'impact. L'autre moitié suivait un programme à faible intensité à la maison.

Les résultats :

- Le groupe entraîné a vu sa densité osseuse augmenter au niveau de la colonne lombaire et se maintenir au niveau du col du fémur, alors qu'elle diminuait dans le groupe témoin.
- Les participantes ont aussi amélioré leur force, leur posture et leurs performances fonctionnelles.
- Un seul effet indésirable mineur a été signalé.

Point crucial : les séances étaient supervisées, avec une progression très graduelle et un apprentissage technique rigoureux. Ce n'est pas un programme à improviser seule.

04

## Ce que je te propose

- Deux à trois séances de renforcement par semaine, avec des exercices qui sollicitent les grands groupes musculaires : squat, soulevé de terre, fentes, tirages, développés.
- Une progression graduelle vers des charges réellement stimulantes, sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, avec une technique irréprochable.
- Des impacts adaptés si ton corps le permet : petits sauts, montées de marches dynamiques, en tenant compte de tes articulations et de ton périnée.
- Du travail d'équilibre, pour prévenir les chutes, qui sont la principale cause de fractures.
- De l'endurance pour le cœur, au moins 150 minutes par semaine d'intensité modérée selon l'OMS.

> **Bien encadré et progressif, l'entraînement en force fait partie des meilleures stratégies pour tes os après la ménopause.**

05

## L'assiette, l'autre pilier

- Le calcium : produits laitiers, eaux minérales riches en calcium, certains légumes verts, amandes, sardines avec arêtes.
- La vitamine D : poissons gras, œufs, exposition modérée au soleil. L'Anses recommande du poisson deux fois par semaine dont un gras. Une supplémentation peut être discutée avec ton médecin.
- Les protéines : réparties sur les repas, pour soutenir le muscle.
- Moins d'alcool et pas de tabac, deux facteurs qui fragilisent les os.

06

## Faire le point avec son médecin

Ton médecin peut évaluer ton risque de fracture et, si besoin, prescrire une ostéodensitométrie, l'examen qui mesure la densité osseuse. Il pourra aussi te parler des traitements possibles, notamment hormonaux, selon ta situation. Si tu as déjà une ostéoporose, l'activité physique reste recommandée, mais le programme doit être adapté avec lui.

## À RETENIR

- Après la ménopause, la perte osseuse et musculaire s'accélère.
- L'os se renforce quand on le met en charge : renforcement musculaire et impacts.
- L'essai LIFTMOR a montré qu'un entraînement lourd, supervisé et progressif améliorait la densité osseuse.
- Équilibre et endurance complètent le programme.
- Calcium, vitamine D, protéines, et un suivi avec son médecin.

## SOURCES


- Watson S.L. et al., High-Intensity Resistance and Impact Training Improves Bone Mineral Density and Physical Function in Postmenopausal Women With Osteopenia and Osteoporosis: The LIFTMOR Randomized Controlled Trial, Journal of Bone and Mineral Research (2018) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28975661/
- Anses, Plus d'activité physique et moins de sédentarité pour une meilleure santé (2016) : https://www.anses.fr/fr/content/plus-dactivite-physique-et-moins-de-sedentarite-pour-une-meilleure-sante
- Anses, Vitamine D : pourquoi et comment assurer un apport suffisant ? : https://www.anses.fr/fr/content/vitamine-d-pourquoi-et-comment-assurer-un-apport-suffisant
- Organisation mondiale de la santé, Lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, en un coup d'œil (2020) : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240014886